UE B3 | Pratiques et interventions infirmières | IFSI 1re année

PARAMÈTRES VITAUX ET BIOLOGIQUES

Cours pour comprendre · Rentrée 2026–2027

D’après le CM de Gaëtan Swinnen (71 diapositives). Mise au point pédagogique et réglementaire au 14 octobre 2026.

FIL ROUGE : **Mesurer → vérifier → comparer → interpréter → alerter → tracer.** Un chiffre isolé ne suffit jamais pour apprécier l’état clinique.

Code des couleurs : rouge = à apprendre par cœur ; bleu = comprendre ; jaune = astuce ; vert = application en stage ; orange = vigilance.

Progression du formateur : cadre légal • physiologie • température • respiration et SpO_2 • pouls • pression artérielle • douleur et conscience • diurèse et BU • glycémie • anthropométrie • alerte NEWS2/SAED.

Limite : les seuils sont des repères pédagogiques ; dans le soin réel, appliquer les prescriptions, dispositifs, protocoles locaux et tenir compte de l’âge et de la situation.

1. Cadre légal et responsabilité

En 2026, le rôle infirmier comprend l'examen clinique, l'analyse des signes et l'orientation des décisions de soins. Les mesures ne sont pas une simple collecte de nombres : elles servent au raisonnement clinique.

Texte officiel	Ce qu'il faut en retenir
Loi n° 2025-581 du 27/06/2025	Évolution des missions infirmières ; reconnaissance de la consultation et du diagnostic infirmiers.
Décret n° 2025-1306 du 24/12/2025	Nouvelle rédaction des articles R.4311-1 et suivants ; entrée en vigueur au 30/06/2026.
Arrêté du 26/06/2026	Actes : rôle propre (art. 1), réalisations pouvant être confiées sous responsabilité IDE (art. 2), actes sur prescription (art. 4 et 5).
Arrêté du 20/02/2026	Référentiel de formation 2026 : cinq domaines, dont B « pratiques cliniques infirmières ».

Rôle propre, réalisation confiée, prescription

• **Rôle propre** : évaluer, repérer, interpréter, décider de surveiller et d'alerter ; mesures et tests à lecture instantanée autorisés dans les listes en vigueur.

• **En collaboration** : un aide-soignant ou un auxiliaire de puériculture peut réaliser certains recueils, notamment des paramètres non invasifs et, dans les conditions prévues par les textes, la glycémie capillaire. L'IDE reste responsable de l'analyse et du suivi.

• **Sur prescription / protocole** : prélèvements et actes invasifs désignés, traitements et gestes relevant de ce cadre. Ne pas confondre recueil et geste diagnostique ou thérapeutique.

En stage : face à une valeur signalée par l'AS, recueillir les symptômes, vérifier la cohérence, consulter le dossier, avertir l'IDE référent et tracer. En tant qu'ESI, ne pas agir seul hors de l'encadrement prévu.

2. Physiologie : ce que surveillent les paramètres

Homéostasie = maintien d'un équilibre interne (température, oxygénation, circulation, eau et glucose). Le corps compense avant de décompenser : l'accélération de la FR ou de la FC peut précéder une hypotension.

Fonction évaluée	Paramètre	Signification
Thermorégulation	T°	Production/perte de chaleur ; inflammation.
Respiration	FR, SpO_2	FR = mouvements ventilatoires ; SpO_2 = saturation de l'hémoglobine en O_2.
Circulation	FC, PA, TRC	Débit et perfusion des organes ; état périphérique.
Fonction rénale/hydratation	Diurèse	Production d'urines, état volémique et perfusion rénale.
Métabolisme	Glycémie	Disponibilité du glucose sanguin.
Neurologie/douleur	ACVPU, Glasgow, EN	État de vigilance et douleur.

À retenir : Une PA apparemment normale n'exclut pas une situation critique. L'évolution par rapport à la valeur habituelle est essentielle.

3. Température corporelle

Thermorégulation : pourquoi la température varie

L'hypothalamus ajuste les réponses du corps autour d'un point de consigne. Le métabolisme, les frissons et la graisse brune produisent de la chaleur ; la vasoconstriction la conserve ; rayonnement, conduction, convection et évaporation la dissipent.

• Variation quotidienne d'environ 0,5 °C ; température plus basse en fin de nuit.

• L'effort, la grossesse, le cycle menstruel et les conditions de mesure influencent la valeur.

• Chez le nouveau-né et la personne âgée, les réponses thermiques sont moins efficaces ; une infection de la personne âgée peut être afébrile.

Situation	Repère	À observer / agir
Normothermie	Env. 36,5–37,5 °C	Selon heure et site ; noter la méthode.
Fièvre	≥ 38 °C au repos	Frissons, inconfort, recherche du contexte clinique.
Hypothermie	< 35 °C	Frissons ou conscience altérée ; prévenir rapidement.
Coup de chaleur	Souvent > 40 °C + signes neurologiques	Urgence : alerter et refroidir selon protocole sans délai.

Fièvre ≠ hyperthermie

Fièvre : le point de consigne hypothalamique augmente (pyrogènes inflammatoires). Frissons lors de l'ascension, chaleur au plateau, sueurs pendant la défervescence. Les antipyrétiques peuvent améliorer le confort.

Hyperthermie : la production ou l'apport de chaleur dépasse la capacité de dissipation, sans augmentation du point de consigne. Les antipyrétiques ne traitent pas le mécanisme : refroidissement rapide si coup de chaleur.

Vigilance : T° élevée + confusion, hypotension, polypnée, marbrures, oligurie ou purpura = alerte immédiate. Ne pas attendre une température supérieure à 40 °C pour réagir à un tableau préoccupant.

Choisir le bon site

Site	Atout	Limite majeure
Axillaire	Facile et non invasif	Sous-estime souvent ; noter site sans correction automatique.
Tympanique	Rapide	Dépend du positionnement, conduit auditif.
Buccale	Assez reproductible	Influencée par boissons et alimentation ; éviter si confusion.
Frontale	Non contact	Sensibilité à la sueur et à l'environnement.
Rectale	Proche centrale	Invasive ; contre-indications et précautions.
Centrale	Mesure continue	Réservée aux situations spécialisées.

Méthode de mesure

1. Identitovigilance, information, hygiène des mains. 2. Patient au repos, thermomètre adapté, embout/protection. 3. Même site à chaque contrôle si possible. 4. Lire, interpréter et tracer : T°, site, heure, traitement antipyrétique récent, symptômes.

Chez l'enfant

Fièvre : > 38 °C en température centrale selon HAS 2016. On vise le **confort** plutôt qu'un chiffre. Boire régulièrement, ne pas trop couvrir, traiter si inconfort selon prescription et RCP. Nourrisson de moins de 3 mois fébrile : évaluation médicale immédiate.

Médicament : paracétamol pédiatrique (référence HAS/Ameli) : habituellement au maximum 60 mg/kg/j, en 4 à 6 prises. Vérifier l'âge, le poids, les contre-indications, la forme et la prescription. Ne pas alterner systématiquement antipyrétiques ; éviter les AINS en contexte infectieux sans indication adaptée.

4. Respiration et saturation pulsée (SpO_2)

La **fréquence respiratoire (FR)** est le nombre de cycles inspiration–expiration par minute. Elle varie selon âge, activité et état clinique. Chez l'adulte calme : **12–20/min**. Compter discrètement pendant **60 secondes**, en observant aussi amplitude, régularité et signes de lutte.

Terme	Définition
Eupnée	Respiration calme, régulière, sans effort.
Tachypnée	FR supérieure à la norme liée à l'âge.
Bradypnée	FR inférieure à la norme.
Polypnée	Respiration rapide, souvent superficielle.
Dyspnée	Difficulté ou gêne respiratoire.
Orthopnée	Dyspnée en position allongée, soulagée assis.
Apnée	Absence de mouvements respiratoires.

Signes d'alerte : FR ≥ 25 ou ≤ 8/min chez l'adulte, tirage, cyanose, difficulté à parler, somnolence ou confusion, agitation, pauses respiratoires, stridor. Un patient dyspnéique s'évalue d'abord cliniquement.

SpO_2 : ce que mesure l'oxymètre

Capteur de lumière : estimation de la proportion d'hémoglobine artérielle oxygénée. En air ambiant, chez l'adulte sans maladie respiratoire, **≥ 95 %** est un repère courant. Sous O_2, les cibles médicales sont souvent **94–98 %** ou **88–92 %** pour certaines personnes à risque d'insuffisance respiratoire hypercapnique.

Le capteur peut être trompé par extrémités froides, mouvements, vernis, faible perfusion ou caractéristiques de pigmentation cutanée. L'intoxication au CO peut afficher une SpO_2 faussement normale. La **SpO_2 ne renseigne pas sur le CO_2** ni directement sur la ventilation.

Stage : noter « SpO_2 93 % à l'air ambiant » ou « SpO_2 95 % sous lunettes O_2 2 L/min », vérifier le signal et évaluer la FR et l'état neurologique. Ne pas modifier l'oxygénothérapie hors prescription/protocole.

5. Fréquence cardiaque et pouls

La **fréquence cardiaque (FC)** est le nombre de battements par minute. Le pouls est l'onde artérielle palpée ; il informe sur le rythme, la fréquence et l'amplitude.

Adulte au repos	Repères
Fréquence habituelle	60 à 100 battements/min
Tachycardie	> 100/min, selon contexte
Bradycardie	< 60/min, parfois physiologique chez sportif / au sommeil
Arythmie	Rythme irrégulier ; confirmer et signaler selon le contexte

Prise : au repos, deux doigts sur le pouls radial, sans pouce ; compter 60 s si irrégulier, examiner régularité, amplitude, symétrie. Sites : radial, huméral/brachial (nourrisson), carotidien ou fémoral selon situation.

Causes possibles de tachycardie : fièvre, douleur, anxiété, hypovolémie, hémorragie, hypoxie, infection sévère. **Bradycardie :** entraînement sportif, médicaments ralentisseurs, hypothermie ou pathologie cardiaque.

Vigilance : les bêtabloquants peuvent limiter la hausse attendue de FC malgré un état grave. Toujours confronter au traitement et à l'état clinique.

6. Pression artérielle (PA)

PAS (systolique) : pression lors de la contraction ventriculaire. **PAD (diastolique)** : pression pendant la relaxation. Unité : mmHg. **PAM** : pression artérielle moyenne, estimation de perfusion des organes.

Formule : PAM ≈ PAD + (PAS − PAD)/3. Exemple : 120/75 → PAM ≈ 90 mmHg. Une PAM **65 mmHg** évoque un risque de perfusion insuffisante dans plusieurs contextes critiques ; toujours interpréter cliniquement.

Mesure correcte

• Repos d'au moins 5 min, vessie vide si possible, pas de café/tabac depuis 30 min.

• Assis, dos soutenu, pieds à plat, jambes décroisées ; bras nu et soutenu à hauteur du cœur.

• Brassard à la bonne taille ; deux mesures espacées d'une à deux minutes ; comparer aux deux bras initialement si faisable.

• Noter le bras, la position, la valeur et l'heure. En arythmie, contrôle manuel/auscultatoire selon le matériel.

Seuils et contexte chez l'adulte

Situation	Repère clinique / pédagogique
HTA en consultation	PAS ≥ 140 mmHg et/ou PAD ≥ 90 mmHg (confirmation nécessaire).
HTA sévère	PAS ≥ 180 et/ou PAD ≥ 110 mmHg : évaluer signes de gravité, alerter selon protocole.
Hypotension	Souvent PAS < 90 mmHg ou baisse marquée par rapport à l'habitude.
Hypotension orthostatique	Baisse de PAS ≥ 20 mmHg et/ou PAD ≥ 10 mmHg après passage debout (mesures couchée puis debout).

Ne pas utiliser sans évaluation : bras avec fistule AV, dispositif vasculaire, blessure, brûlure, lymphœdème. Après curage axillaire sans lymphœdème, le risque et les recommandations sont nuancés : choisir le côté selon évaluation et protocole, et ne pas présenter toute chirurgie mammaire comme une interdiction absolue.

Chez l'enfant

La PA normale dépend de l'âge, du sexe et de la taille : utiliser les courbes percentiles. En urgence, les repères PALS d'hypotension systolique sont : **< 60 mmHg chez le nouveau-né**, **< 70** de 1 à 12 mois, **< 70 + 2 × âge** de 1 à 10 ans, **< 90** au-delà de 10 ans. Hypotension tardive : rechercher auparavant tachycardie, TRC prolongé et changement de comportement.

---

7. Douleur et état de conscience

Douleur

La douleur est une expérience subjective. Privilégier l'auto-évaluation : **EN 0–10**, EVA, EVS ; observer localisation, type, durée, facteurs aggravants, retentissement et réponses au traitement. Si la communication est impossible, employer une échelle adaptée (Algoplus, EVENDOL, etc.).

Conduite IDE : mesurer et tracer avant/après le traitement, surveiller effets indésirables et efficacité ; transmettre si douleur inhabituelle ou non soulagée.

Conscience

Échelle	Ce qu'on observe
ACVPU	A = alerte ; C = confusion nouvelle ; V = répond à la voix ; P = répond à la douleur ; U = aucune réponse.
Glasgow (GCS)	Ouverture des yeux 1–4 ; réponse verbale 1–5 ; motrice 1–6 ; total 3–15.
Pupilles	Taille, symétrie, réactivité ; myosis, mydriase, anisocorie.

Urgence : confusion récente, baisse du Glasgow, pupilles asymétriques nouvelles, convulsions ou absence de réponse. **Glasgow ≤ 8** : atteinte sévère de la conscience nécessitant protection et évaluation urgente des voies aériennes.

---

8. Diurèse et bandelette urinaire

Diurèse : quantité d'urines produites dans une période donnée ; bonne surveillance de la perfusion rénale, du bilan hydrique et de la fonction urinaire, sans être une preuve isolée du fonctionnement rénal.

Terme	Repère adulte
Diurèse usuelle	Env. 0,5–1 mL/kg/h (variable avec les apports).
Oligurie	< 0,5 mL/kg/h sur plusieurs heures, ou < 500 mL/24 h selon le contexte.
Anurie	< 100 mL/24 h.
Polyurie	> 3 L/24 h.
Rétention	Vessie pleine mais évacuation impossible ; distincte de l'anurie.

Terme	Repère adulte
Dysurie / pollakiurie	Difficulté à uriner / mictions fréquentes.

Recueil des urines 24 h : vider la vessie à l'heure de début et jeter les urines, collecter toutes les mictions suivantes, recueillir la dernière à la même heure le lendemain, conserver selon les indications du laboratoire. Noter volume et intégration dans bilan entrées/sorties.

BU : ce que signifient les plages

Plage	Interprétation possible (non spécifique)
Leucocytes	Inflammation/infection urinaire.
Nitrites	Certaines bactéries ; négatif n'exclut pas une infection.
Protéines	Atteinte rénale, fièvre, effort, etc.
Sang	Hématurie ou contamination.
Glucose / cétones	Glycosurie / cétose (à confronter à la glycémie).
pH / densité	Acidité et concentration des urines.

Technique : prélèvement d'urines fraîches, milieu de jet quand indiqué ; bandelette non périmée ; temps de lecture exact selon notice ; noter résultat, contexte et symptômes.

Attention : une BU positive isolée chez une personne asymptomatique, notamment âgée, ne suffit pas à diagnostiquer une infection urinaire ni à justifier un antibiotique. Adapter l'ECBU aux indications médicales.

9. Glycémie capillaire et capteurs

La **glycémie** est la concentration de glucose dans le sang. **1 g/L ≈ 5,55 mmol/L.** Le prélèvement veineux de laboratoire est la référence diagnostique ; le lecteur capillaire rend une valeur immédiatement ; le capteur continu mesure le glucose interstitiel avec décalage variable.

Situations fréquentes	Repères
Hypoglycémie	< 0,70 g/L (3,9 mmol/L).
Hypoglycémie niveau 2	< 0,54 g/L (3,0 mmol/L).
Niveau 3	Épisode sévère nécessitant l'aide d'une autre personne, indépendamment d'un seuil chiffré.
Glycémie à jeun	< 1,10 g/L : norme usuelle de laboratoire ; ≥ 1,26 g/L à confirmer pour diagnostiquer un diabète.
Temps dans la cible, capteur	Objectif individualisé ; souvent > 70 % entre 0,70 et 1,80 g/L chez l'adulte diabétique non fragile.

Mesurer proprement et interpréter

Identitovigilance ; mains lavées et bien séchées ; bandelette compatible non périmée ; prélèvement latéral sur doigt, sans écraser ni presser fortement ; noter unité, horaire, repas, symptômes et actions. En cas de valeur incohérente, répéter et vérifier le lecteur.

Capteurs de glucose : les mesures interstitielles suivent les variations sanguines avec un retard (souvent 5–15 min lors de changements rapides). Certains dispositifs autorisent des décisions

thérapeutiques hors hôpital sans confirmation systématique ; en établissement, appliquer le protocole, et confirmer au capillaire/laboratoire en cas de symptômes discordants, hypoglycémie suspectée ou situation critique.

Hypoglycémie : sueurs, tremblements, pâleur, faim, confusion, troubles neurologiques. Si conscient et déglutition sûre : resucrage rapide selon protocole ; si conscience altérée : ne rien donner par bouche, alerter immédiatement, prise en charge selon protocole.

Pédiatrie et nouveau-né

Les seuils néonataux sont **spécifiques au terme, à l'âge postnatal et au risque** et relèvent des protocoles de néonatologie ; une mesure capillaire basse chez le nouveau-né peut nécessiter confirmation biologique. Chez l'enfant diabétique, associer les parents et appliquer le protocole individuel.

---

10. Poids, taille, IMC et croissance

Mesurer dans des conditions reproductibles : même balance, moment, vêtements, posture. Une variation pondérale rapide peut traduire une modification du bilan hydrique. **IMC = masse (kg)/[taille (m)]².**

IMC adulte OMS	Catégorie
< 18,5	Insuffisance pondérale
18,5–24,9	Corpulence habituelle
25,0–29,9	Surpoids
≥ 30	Obésité

Chez l'enfant, ne jamais utiliser les seuils adultes : reporter taille, poids et corpulence sur les **courbes selon âge et sexe** ; surveiller aussi le périmètre crânien du nourrisson. La trajectoire est plus informative qu'un point isolé.

---

11. De la mesure à l'alerte

4 réflexes pour raisonner

1. Vérifier la fiabilité ; **2. Comparer** à la situation habituelle ; **3. Croiser** les paramètres ; **4. Contextualiser** : terrain, médicaments, douleur, événement récent.

Score NEWS2 : dépistage de dégradation (adulte)

NEWS2 additionne FR, SpO_2, apport d'oxygène, pression systolique, pouls, conscience et température. L'échelle 2 de SpO_2 est réservée, sur décision clinique documentée, aux patients présentant une insuffisance respiratoire hypercapnique confirmée. Ne pas l'utiliser automatiquement devant toute BPCO.

Paramètre	0 point	1 point	2 points	3 points
FR/min	12–20	9–11	21–24	≤ 8 ou ≥ 25
SpO_2 échelle 1	≥ 96	94–95	92–93	≤ 91
O_2 supplémentaire	Air ambiant	—	Sous O_2	—

Paramètre	0 point	1 point	2 points	3 points
PAS mmHg	111–219	101–110	91–100	≤ 90 ou ≥ 220
FC/min	51–90	91–110	111–130	≤ 40 ou ≥ 131
Conscience	Alerte	—	—	Confusion nouvelle / V, P ou U
T° °C	36,1–38,0	35,1–36,0 / 38,1–39,0	≥ 39,1	≤ 35,0

Complément : FC 41–50/min = 1 point ; score oxygène sous supplément = 2 points. Voir fiche NEWS2 officielle pour l'ensemble des cases et les protocoles institutionnels.

NEWS2	Réponse indicative d'après RCP / protocole local
0	Surveillance habituelle ; fréquence minimale typique toutes les 12 h.
1 à 4	Évaluation IDE, surveillance plus rapprochée (souvent toutes les 4–6 h).
3 sur un seul paramètre	Avis médical rapide / surveillance rapprochée.
5 à 6	Réponse urgente ; avis clinique rapide.
≥ 7	Réponse d'urgence / équipe de soins critiques.

NEWS2 n'est pas un diagnostic de sepsis et ne doit pas retarder une alerte clinique. Pas d'application standard à la pédiatrie ou la grossesse.

SAED (HAS) : parler sans oublier

S	Situation : qui appelle, qui est le patient et pourquoi maintenant ?
A	Antécédents : contexte, opération, antécédents, traitements.
E	Évaluation : chiffres, comparaison, observations, actions déjà réalisées.
D	Demande : ce qui est attendu, délai et confirmation des consignes.

Traçabilité : date/heure ; méthode/site ; valeur et unité ; observations ; résultats antérieurs ; actions ; identité de la personne alertée ; consignes ; réévaluation.

Cas clinique corrigé : M. R., 76 ans, J2 PTH

Situation du CM : T° 38,4 °C ; FC 104/min ; PA 105/62 (habituellement 140/80) ; FR 22/min ; SpO_2 94 % en air ; conscient et orienté ; diurèse 180 mL/6 h pour 70 kg.

Calcul	Résultat et interprétation
NEWS2	T° 1 + FC 1 + PAS 1 + FR 2 + SpO_2 1 + air 0 + conscience 0 = **6**.
PAM	62 + (105−62)/3 ≈ **76 mmHg**. N'exclut pas un début d'instabilité.
Diurèse	180/6 = **30 mL/h** ; seuil 0,5 × 70 = **35 mL/h** → oligurie.
Variation PAS	105 vs 140 habituel : **−35 mmHg** ; association inquiétante.

Analyse : le cumul fièvre, tachycardie, polypnée, hypotension relative, baisse de diurèse suggère un état pathologique évolutif potentiellement grave, dont sepsis parmi les hypothèses. Il ne s'agit **pas d'un diagnostic affirmé**.

Rôle infirmier / ESI : alerter sans attendre, vérifier conscience/FR/PA/SpO_2, surveiller les paramètres et la diurèse, rechercher rétention si indication, préparer le dossier, appliquer les prescriptions reçues et tout tracer.

Exemple SAED : « Je vous appelle pour M. R., 76 ans, à J2 de prothèse de hanche, en dégradation clinique. Hypertendu traité, PAS habituellement 140. Aujourd'hui T 38,4, FR 22, FC 104, PA 105/62, SpO_2 94 % à l'air, diurèse 30 mL/h, NEWS2 6. Pouvez-vous l'évaluer rapidement ? Je poursuis la surveillance rapprochée selon le protocole. »

Pédiatrie : repères comparatifs

Chez l'enfant, les fréquences diminuent avec l'âge. Valeurs approximatives en état calme :

Âge	FC/min	FR/min	Seuil d'hypotension systolique
Nouveau-né	90–180	40–60	< 60 mmHg
1–12 mois	~100–180	~25–50	< 70 mmHg
2 ans	80–140	20–28	< 74 mmHg
6 ans	75–115	18–24	< 82 mmHg
> 10 ans	~60–110	16–20	< 90 mmHg

Alerter : tirage, geignement, cyanose, refus de boire, hypotonie, fontanelle bombée, perte d'interactions ou changement comportemental, TRC prolongé. La PA chute parfois tardivement, même en choc.

Questions d'entraînement

Q1. Un patient a SpO_2 97 % sous O_2 mais sa FR est de 7/min. Situation rassurante ? **Q2.** Que noter pour une température tympanique de 38,2 °C sous paracétamol ? **Q3.** PAM pour 90/60 ? **Q4.** Quelles quatre parties du SAED ? **Q5.** Un capteur affiche 0,95 g/L mais le patient transpire et tremble : conduite ?

Corrigé : Q1 Non, risque d'hypoventilation ; évaluer/alerter. Q2 Valeur, site, heure, contexte et antipyrétique. Q3 60 + (90−60)/3 = 70 mmHg. Q4 Situation, Antécédents, Évaluation, Demande. Q5 Contrôle capillaire rapide, prise en charge de symptômes selon protocole, ne pas se fier seul au capteur.

Lexique utile pour les évaluations

Terme	Définition courte
Homéostasie	Équilibre du milieu interne.
Hypoxémie	Baisse d'oxygène dans le sang artériel.
Hypoventilation	Ventilation insuffisante pouvant entraîner une rétention de CO_2.
Hypovolémie	Baisse du volume sanguin circulant.

Terme	Définition courte
TRC	Temps de recoloration cutanée : repère périphérique.
Oligurie	Production d’urine diminuée.
Anurie	Quasi-absence de production urinaire.
Orthopnée	Dyspnée soulagée par la position assise.
PAS / PAD / PAM	Pressions artérielles systolique / diastolique / moyenne.
ACVPU	Échelle rapide d’état neurologique.
NEWS2	Score de détection de dégradation clinique, adulte.
SAED	Outil de transmission structurée.

Sources et vérifications au 14 octobre 2026

CM fourni (Gaëtan Swinnen), « Les paramètres vitaux et biologiques », 71 diapositives. — Source pédagogique primaire.
Loi n° 2025-581, 27 juin 2025 — https://www.legifrance.gouv.fr
Décret n° 2025-1306, 24 déc. 2025 — https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000053165854/
Arrêté du 26 juin 2026 fixant la liste des actes IDE — https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/6/26/SFHH2610764A/jo/texte
Arrêté du 20 février 2026 relatif au DEI (annexe III) — https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000053568913/
HAS, Prise en charge de la fièvre chez l’enfant, octobre 2016 — https://www.has-sante.fr/jcms/c_2674284/
HAS, SAED, novembre 2014 — https://www.has-sante.fr/jcms/c_1776178/fr/saed-un-guide-pour-faciliter-la-communication-entre-professionnels-de-sante
Royal College of Physicians, NEWS2, 2017 — https://www.rcp.ac.uk/resources/national-early-warning-score-news-2/
ADA, Standards of Care 2025, Diabetes Technology et Hospital Care — https://diabetesjournals.org/care/article/48/Supplement_1/S146/157557/7-Diabetes-Technology-Standards-of-Care-in

Points de nuance par rapport au CM : usage décisionnel possible de certains capteurs de glycémie hors soins critiques ; vérification capillaire selon contexte hospitalier. Interprétation des prises de PA après chirurgie mammaire individualisée. NEWS2 SpO_2 échelle 2 uniquement si indication médicale documentée.